

Krótsze zestawy *dłuższa faza stabilizacji*

Standardowy 8-fazowy protokół EMDR wymaga modyfikacji w C-PTSD. Bez RDI i okna tolerancji może retraumatyzować — szczególnie u pacjentów dysocjacyjnych.

CZAS: 6–24 mies. (zależy od stabilizacji), 60–90 min sesja **REALIZACJA:** Faza 2 — po solidnej Fazie 1

ŹRÓDŁO: Shapiro (2018, *Eye Movement Desensitization and Reprocessing*); Korn & Leeds (2002, RDI); Chen i in. (2015, metaanaliza 26 RCT, $d = 0,66-1,01$); Hofmann & Nickerson (2018); WHO (2013); NICE (2018)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **czym jest EMDR**: 8-fazowy protokół Shapiro, mechanizm bilateralnej stymulacji, ewidencja w PTSD. W sekcji 02 — **pięć modyfikacji** dla C-PTSD: wydłużona stabilizacja, RDI, krótsze zestawy, ostrożność z dysocjacją, dobór celów. Sekcja 03 — **twoja gotowość**: kryteria, kiedy EMDR jest bezpieczne. Sekcja 04 — pytania do specjalisty EMDR.

DLACZEGO TO DZIAŁA

EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*, Shapiro, 1989, 2018) — terapia traumy oparta na **bilateralnej stymulacji** (ruchy oczu, naprzemienne stuknięcia tzw. *tapping*, dźwięki) podczas przetwarzania wspomnień traumatycznych. Mechanizm: bilateralna stymulacja ułatwia **rekonsolidację pamięci** — wspomnienie traumatyczne zostaje zintegrowane z kontekstem („to było *wtedy*, nie jest *teraz*”) i traci intensywność emocjonalną. Chen i in. (2015, metaanaliza 26 RCT): EMDR jest skuteczne w PTSD ($d = 0,66-1,01$). **WHO (2013)** i **NICE (2018)** rekomendują jako leczenie pierwszego rzutu w PTSD. **W C-PTSD wymaga modyfikacji.** Standardowy protokół 8-fazowy: (1) historia, (2) przygotowanie, (3) ocena celu, (4) odwracanie, (5) instalacja pozytywnego przekonania, (6) skan ciała, (7) zamknięcie, (8) ponowna ocena. W C-PTSD każda faza wymaga adaptacji. Hofmann i Nickerson (2018): EMDR jest **obiecujące** w C-PTSD, ale wymaga **większej elastyczności i dłuższego czasu. Pięć kluczowych modyfikacji**: (1) **wydłużona faza stabilizacji** (Faza 2 protokołu — zasoby, bezpieczne miejsce, kontener) — tygodnie do miesięcy zamiast 1–2 sesji; (2) **RDI** (*Resource Development and Installation*, Korn & Leeds, 2002) — 4–8 sesji instalacji zasobów **przed** pierwszym celem traumy: bezpieczne miejsce, figury wspierające, zasoby ciała, kotwiczone bilateralną stymulacją; (3) **krótsze zestawy** bilateralnej stymulacji — 10–15 ruchów zamiast 24–30; częste sprawdzanie okna tolerancji; (4) **ostrożność z dysocjacją** — DES-II do oceny; w podtypie dysocjacyjnym dodatkowa stabilizacja, modyfikacje sesji, niekiedy 12+ sesji Fazy 1 najpierw; (5) **dobór celów** — nie tylko „najgorsze wspomnienie”, ale wczesnodziecięce wspomnienia przywiązaniowe, sceny defektywności/wstydu, momenty „*kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem zły/-a*”. Bez RDI i okna tolerancji EMDR może **retraumatyzować** — pacjentka w pierwszej sesji dysocjuje, traci kontakt emocjonalny, sesja kończy się bez zamknięcia.

01

EMDR — podstawa

BILATERALNA STYMULACJA

Ruchy oczu, *tapping*, dźwięki naprzemienne. Pacjent przywołuje wspomnienie, jednocześnie podążając wzrokiem za palcami terapeuty. Stymulacja ułatwia rekonsolidację pamięci.

8-FAZOWY PROTOKÓŁ

Historia → przygotowanie → ocena celu → odwracanie → instalacja przekonania → skan ciała → zamknięcie → ponowna ocena. Standard dla PTSD; w C-PTSD każda faza modyfikowana.

EWIDENCJA

Chen i in. (2015, metaanaliza 26 RCT): $d = 0,66-1,01$. WHO (2013) i NICE (2018): leczenie pierwszego rzutu w PTSD. W C-PTSD ewidencja słabsza, ale obiecująca (Hofmann & Nickerson, 2018).

02 Pięć modyfikacji EMDR dla C-PTSD

MODYFIKACJA	CO KONKRETNIE
1 · Dłuższa stabilizacja	Faza 2 protokołu (zasoby, kontener) — <i>tygodnie do miesięcy</i> , nie 1–2 sesje. Bez okna tolerancji nie ma sensownego przetwarzania.
2 · RDI (Korn & Leeds)	<i>Resource Development and Installation</i> — 4–8 sesji instalacji zasobów przed pierwszym celem: bezpieczne miejsce, figury, zasoby ciała. Kotwiczone bilateralną stymulacją.
3 · Krótsze zestawy	10–15 ruchów zamiast 24–30. Częste sprawdzanie okna tolerancji. Gotowość do przerwania i restabilizacji w trakcie sesji.
4 · Ostrożność z dysocjacją	DES-II do oceny. W podtypie dysocjacyjnym 12+ sesji Fazy 1, dodatkowe stabilizatory, niekiedy odraczanie EMDR na rzecz innej modalności (sensomotorycznej, IFS).
5 · Dobór celów	Nie tylko „najgorsze wspomnienie” — wczesnodziecięce wspomnienia przywiązaniowe, sceny wstydu, „ <i>kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem zły/-a</i> ”. Od mniej intensywnych do bardziej.

03 Moja gotowość do EMDR + pytania do specjalisty

MOJE OBECNE KRYTERIA STABILIZACJI

— brak ryzyka suicydalnego, okno tolerancji, ≥ 3 strategie grounding, alians, zgoda; zaznacz, co już mam

CZY DOŚWIADCZAM DYSOCJACJI

— jaką formę, jak często; warto zrobić DES-II z klinicystą przed EMDR

MOJE PYTANIA DO SPECJALISTY EMDR

— np. „czy planujesz RDI przed celami?”, „ile sesji stabilizacji?”, „jak postępujesz przy dysocjacji w sesji?”

MOJA SIEĆ WSPARCIA NA OKRES EMDR

— EMDR aktywuje między sesjami; kto będzie dostępny, jeśli będę potrzebował/-a wsparcia

Klucz: EMDR jest **skuteczny** w C-PTSD, gdy stosowany z modyfikacjami i przez specjalistę znającego specyfikę traumy złożonej. Standardowy protokół z PTSD (krótkie sesje stabilizacji, długie zestawy, „najgorsze wspomnienie” jako pierwszy cel) *może retraumatyzować* — pacjentka w pierwszej sesji dysocjuje, sesja kończy się bez zamknięcia, klient wraca do domu w gorszym stanie niż przyszedł. Bez RDI (Korn & Leeds, 2002) brakuje „kotwicy”, do której można wrócić w trakcie sesji. Pytanie kluczowe do specjalisty: „czy planujesz pracę zgodnie z protokołem dla C-PTSD, z wydłużoną fazą stabilizacji i RDI?” — terapeuta, który mówi „nie potrzebujemy tego, EMDR jest EMDR”, nie ma kompetencji do pracy z C-PTSD. Hofmann i Nickerson (2018) i ISTSS (2019) jednoznacznie zalecają adaptację.

△ EMDR aktywuje przetwarzanie między sesjami (sny, intruzje, wspomnienia). To normalna część procesu, nie znak, że terapia szkodzi — pod warunkiem że masz strategie regulacji. Jeśli aktywacja przekracza okno tolerancji (samookaleczenie, dłuższe dysocjacje, myśli suicydalne) — natychmiastowy kontakt z terapeutą i czasowe wstrzymanie EMDR. 116 123 w kryzysie.